Клинические рекомендации

Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G45.0** — Синдром вертебробазилярной артериальной системы **G45.1** — Синдром сонной артерии (полушарный) **G45.2** — Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий **G45.3** — Преходящая слепота **G45.4** — Транзиторная глобальная амнезия **G45.8** — Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы **G45.9** — Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная **G46.0** — Синдром средней мозговой артерии (I66.0+) **G46.1** — Синдром передней мозговой артерии (I66.1+) **G46.2** — Синдром задней мозговой артерии (I66.2+) **G46.3** — Синдром инсульта в стволе головного мозга (I60-I67+) **G46.4** — Синдром мозжечкового инсульта (I60-I67+) **G46.5** — Чисто двигательный лакунарный синдром (I60-I67+) **G46.6** — Чисто чувствительный лакунарный синдром (I60-I67+) **G46.7** — Другие лакунарные синдромы (I60-I67+) **G46.8** — Другие сосудистые синдромы головного мозга при цереброваскулярных болезнях (I60-I67+) **I63.0** — Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий **I63.1** — Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий **I63.2** — Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий **I63.3** — Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий **I63.4** — Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий **I63.5** — Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий **I63.6** — Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный **I63.8** — Другой инфаркт мозга **I63.9** — Инфаркт мозга неуточненный **I64** — Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт **I65.0** — Закупорка и стеноз позвоночной артерии **I65.1** — Закупорка и стеноз базилярной артерии **I65.2** — Закупорка и стеноз сонной артерии **I65.3** — Закупорка и стеноз множественных и двусторонних прецеребральных артерий **I65.8** — Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий **I65.9** — Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной артерии **I66.0** — Закупорка и стеноз средней мозговой артерии **I66.1** — Закупорка и стеноз передней мозговой артерии **I66.2** — Закупорка и стеноз задней мозговой артерии **I66.3** — Закупорка и стеноз мозжечковых артерий **I66.4** — Закупорка и стеноз множественных и двусторонних артерий мозга **I66.8** — Закупорка и стеноз другой артерии мозга **I66.9** — Закупорка и стеноз артерии мозга неуточненной **I67.6** — Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы

Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Национальная ассоциация по борьбе с инсультом; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Межрегиональная общественная организация "Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/814_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Оценка функции глотания 3

4. Лечение 3

4.1 Дыхательные пути 3

4.2 Питание при дисфагии 4

4.3 Сиалорея 4

5. Источник и актуальность 4

5.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 4

1. Основные положения

- Ишемический инсульт — клинический синдром, вызванный фокальным инфарктом головного мозга.
- Головокружение и нистагм у пациента с подозрением на инсульт — повод подозревать вертебробазилярный инсульт. У детей среди «масок инсульта» встречается паралич Белла.
- Функцию глотания оценивают всем пациентам до приёма пищи и лекарств внутрь, **в первые 3 ч** от поступления в палату реанимации; при дисфагии устанавливают назогастральный зонд.
- При прогнозе длительной ИВЛ или выраженной дисфагии рассматривают раннюю трахеостомию — **в первые 7 суток** от начала ИВЛ.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Ишемический инсульт (ИИ) — клинический синдром, вызванный фокальным инфарктом головного мозга.

2.2 Клиническая картина

Головокружение и нистагм у пациентов с подозрением на инсульт заставляют подозревать вертебробазилярный инсульт.

Наиболее частые «маски инсульта» у детей

1. мигрень — 30%;
2. эпилепсия — 16,4%;
3. паралич Белла — 10,4%;
4. конверсионное расстройство — 6,4%;
5. синкопальное состояние — 5%.

3. Диагностика

3.1 Оценка функции глотания

Всем пациентам с ишемическим инсультом или ТИА оценивают функцию глотания для выявления ранних признаков дисфагии. Исходный тест проводят до приёма пищи или лекарств внутрь **в течение первых 3 ч** от поступления в палату реанимации или интенсивной терапии.

Дисфагия — фактор риска аспирационной пневмонии и связана с более высокой смертностью. Скрининг снижает риск пневмонии (1,9% против 13,1%).

Тест на дисфагию («трёхглотковая проба» с пульсоксиметром) проводят **в первые 24 ч**; при невозможности тестирования или выявленной дисфагии устанавливают назогастральный зонд.

4. Лечение

4.1 Дыхательные пути

При снижении уровня сознания или развитии бульбарной дисфункции поддерживают проходимость дыхательных путей для профилактики аспирационных осложнений.

Взрослым пациентам, которым прогнозируется продолжительная ИВЛ или диагностирована выраженная дисфагия, рассматривают раннюю трахеостомию **в первые 7 суток** от начала ИВЛ.

Ранняя трахеостомия снижает риск спонтанной экстубации, повышает комфорт по сравнению с оротрахеальной интубацией, облегчает санацию трахеобронхиального дерева.

4.2 Питание при дисфагии

При установленной дисфагии устанавливают назогастральный зонд — для профилактики аспирации и кормления.

При сохраняющейся потребности в зондовом питании рассматривают чрескожную гастростому **через 2–4 недели** от начала заболевания.

Для снижения риска пневмонии выполняется протокол гигиены полости рта.

4.3 Сиалорея

При хронической сиалорее применяют ботулинический токсин типа А — для снижения риска аспирационных осложнений.

---

5. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	814_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Национальная ассоциация по борьбе с инсультом; Ассоциация нейрохирургов России; Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов; Союз реабилитологов России
Пациенты	Взрослые и дети

5.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.